Circuit du médicament en ESMS

De la prescription à la traçabilité : qui fait quoi, ce qui est obligatoire, ce que regarde l'évaluateur.
EHPAD · FAM · EAM · MAS · IME sans pharmacie à usage intérieur (PUI)

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

À RETENIR

Chaque étape a un responsable et laisse une trace : prescrire → dispenser → stocker → préparer → administrer ou aider à la prise → tracer la prise effective, y compris les non-administrations.

Sources : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, guide circuit du médicament MAS/FAM sans PUI, mai 2016

1 · PRESCRIRE

- Prescription **écrite, datée, signée, nominative** et lisible ; la préparation se fait **à partir de la prescription, sans retranscription**.
- Le libellé précise si l'intervention d'un **auxiliaire médical (IDE)** est nécessaire : c'est lui qui distingue l'aide à la prise (acte de la vie courante) du soin infirmier.
- Traitement « si besoin » : indication, dose, intervalle minimal et dose maximale sur 24 h — voir le **protocole de collaboration DOTR « si besoin »**.
- **Écraser ou ouvrir une gélule** : décision avec le prescripteur et le pharmacien, rechercher une autre forme galénique ; liste des médicaments écrasables sur l'Espace VMS.

Sources : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, guide circuit du médicament MAS/FAM sans PUI, mai 2016 · CASF L313-26 · OMéDIT Normandie / SFPC, liste des médicaments écrasables

2 · DISPENSER ET STOCKER

- EHPAD sans PUI : **convention avec une ou plusieurs officines** et **pharmacien référent** (obligatoire). Autres ESMS : convention sur modèle OMéDIT recommandée.
- PDA par l'officine ou par l'IDE (pas de référentiel PDA opposable publié).
- **Local ou armoire fermé** (clé, digicode, badge), **casier individuel nominatif**.
- **Stupéfiants** : rangement séparé fermé à clé ; vol ou détournement → police, ARS, ANSM ; registre et inventaire recommandés.
- **Froid** : réfrigérateur dédié, **+2 à +8 °C**, relevé de température tracé. **Périmés et traitements arrêtés** : retour à la pharmacie, jamais de stock parallèle.

Sources : CSP L5126-10 et L5125-1-1 A · OMéDIT Île-de-France, « Que dit la loi sur la PECM en EHPAD ? », 2024 · CSP R5126-109 (cité par l'OMéDIT IDF) · ARS Auvergne-Rhône-Alpes, guide circuit du médicament MAS/FAM sans PUI, mai 2016

3 · PRÉPARER ET ADMINISTRER (IDE)

- L'administration, préparation comprise, relève de l'IDE sur prescription.
- Règle des **5B** : bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment.
- Vérifier l'**identité** avant chaque prise ; idéalement, la même personne distribue, administre et trace.
- Écraser **médicament par médicament**, juste avant la prise ; nettoyer le broyeur.

Sources : Décret n° 2025-1306 du 24/12/2025 et arrêté du 26/06/2026 (actes infirmiers) · HAS, Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments, 2011 · ARS Auvergne-Rhône-Alpes, guide circuit du médicament MAS/FAM sans PUI, mai 2016

4 · AIDE À LA PRISE PAR UN NON-SOIGNANT

Possible **seulement si toutes les conditions** sont réunies :

- personne sans autonomie suffisante, traitement prescrit par un médecin ;
- mode de prise **sans difficulté d'administration ni apprentissage particulier** ;
- prescription **sans mention** d'un auxiliaire médical ;
- **protocole de soins** élaboré avec l'équipe soignante (doses, moments de prise) ; médicaments **préparés au préalable par l'IDE**.

Confiés par l'IDE (R4311-5) — AS / AP : aide à la prise (non injectable), collyres, surveillance des effets secondaires. Accomp. éducatif et social : vérification de la prise.

Sources : CASF L313-26 · ARS Auvergne-Rhône-Alpes, guide circuit du médicament MAS/FAM sans PUI, mai 2016 · Décret n° 2025-1306 du 24/12/2025 et arrêté du 26/06/2026 (actes infirmiers)

5 · TRACER

- Enregistrer la **prise effective** : date, heure, intervenant, incident éventuel — après la prise, jamais à l'avance.
- Toute **non-administration** est tracée et motivée (refus, absence, vomissement, sommeil…) ; si elle se répète : IDE puis médecin.
- Voir les protocoles AS/Éduc « Refus », « Oubli », « Erreur médicamenteuse ».

Évaluation HAS

Critère **impératif 3.6.2** du référentiel ESSMS : « Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament ».
Auto-évaluation : HAS, ANAP, OMéDIT.

Sources : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, guide circuit du médicament MAS/FAM sans PUI, mai 2016 · HAS, référentiel d'évaluation des ESSMS, critère impératif 3.6.2 · HAS, Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments, 2011 · ANAP, Inter Diag Médicaments

MÉDICAMENTS À RISQUE — « NEVER EVENTS »

Parmi les 16 never events de l'ANSM, ceux qui concernent le plus les ESMS :

- anticoagulants · insulines · méthotrexate oral ou sous-cutané (rythme **hebdomadaire**) · colchicine · méthadone · chlorure de potassium injectable ;
- voie parentérale au lieu de la voie orale ou **entérale** (sondes, gastrostomie) · gaz médicaux (oxygène) · confusion d'unidoses plastiques.
- Repérer ces médicaments dans le plan de soins et en parler en équipe (proposition DOTR).

Sources : ANSM, liste des never events, mise à jour 18/09/2025 · proposition DOTR

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical. Circuit à valider aussi avec le pharmacien référent. Réforme infirmière (décret n° 2025-1306, arrêté du 26/06/2026) : R4311-4 rôle propre, R4311-5 actes confiés, R4311-6 rôle sur prescription.

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.